38. 実習2：生殖器

所要時間：09:17 学習シート

コース概要

このビデオでは、生体力学における生殖器系に関する実践的なテクニックを深く掘り下げ、患者の体のニーズに合わせてどのように位置付け、感じ取り、対応するかを教えています。重要な概念には、中立の重要性、意識的な接触、腹膜嚢や子宮前立腺領域などのデリケートな領域の探索が含まれます。学生は、エネルギー再編成のプロセスを開始し、体の信号を認識する方法を学び、困難な出産などの出来事の後に調和と治癒に適した空間を作り出すことができます。

実践2：生殖器系 - 生体力学

初期アプローチ：ポジショニングと知覚

私は**中立性**の状態に身を置き、呼吸に集中し、**プラーナ**を受け入れます。

私は優しく手を体に置き、**第三誘導体結節**に触れます。私のアプローチは押し付けるのではなく、身を委ねることです。

私はその人の**誕生軸**を特定し、それが適切に中央に位置していることを確認します。私の注意は周囲の空間に向けられます。それが私を導くからです。

片側にわずかな**圧迫**を感じますが、すぐに修正しようとはしません。反対側はよりリラックスしているように見えます。この観察は予備的な段階です。

接触の確立：骨盤のボウル

私は新しい接触点のために位置を変えます。私の手は**臀部**に軽く置かれ、母指球は**大転子**に向けられます。

私は骨盤を包み込むように**ボウル**のような接触を形成します。私の手はその位置を意識していますが、私の注意の90%は外側、空間に向けられています。

私はその人の中立が徐々に確立するのを待ちます。目標は私たちの中立が出会うことであり、プロセスが自然に進むことを可能にします。

この出会いが起こるなら、私はプロセスに任せます。起こらないなら、異なる介入が必要かもしれません。周囲の生命が最も効果的なガイドです。

動きと調和の知覚

空間の微妙な動きが現れます。私はこの点に向かい、そこでプロセスが始まります。

私はその人に感覚について尋ねます。彼女は右から左への**波**、波の後に再平衡化が起こると説明します。

私は自分の感覚を確認します。それは異なりますが、**調和**はまだ確立されていません。**対称性**は体にも生命にも存在しませんが、調和が求められます。

私は探索を続け、必要であればその人に反対側に変わるように促します。

接触の深化：骨盤のサポートと支点

私は再び**骨盤**を取りますが、今回はより低い位置、**坐骨**のレベルです。その人は臀部を上げて私の手の配置を容易にします。手は平らでリラックスしている必要があります。

原則は同じです。彼女は空間に運ばれているかのようで、私は非常にリラックスしています。これには**忍耐**が必要です。

次に、私は頭頂部に**支点**を作り、私の手で三角形を形成します。これにより、正中線の周りの空間で作業することができます。

潮のようなわずかな動きは、その人の内在的なプロセスが活発であることを示します。

子宮前立腺領域と腹膜

私は**恥骨**のすぐ上に、特定の片手を置いて位置します。徐々に、その人は身を委ねます。

ミューラー管や**ウォルフ管**を含む、正中線に収束する**腹膜嚢**全体、力の線を感じることが不可欠です。

私の手が置かれるにつれて、すべてが前立腺または子宮のレベルで集まり、再集中するように見えます。これは腹膜の集中です。

私は**地球靭帯**、**鎌状靭帯**、そして腹膜全体、および後部壁側腹膜を意識しています。

この接触は、**難産**や**帝王切開**の後、子宮がそのエネルギー的完全性を取り戻していない場合に特に興味深いものです。

エネルギーの再編成と熱

プロセスが始まると、**振動**の変化が知覚され、しばしば**熱**の感覚を伴います。これは体の熱力学の兆候です。

最初、一部の患者はわずかな痛みを感じることがあり、非常にリラックスした手が必要です。

私は常に**微結晶**場に集中し、その人の呼吸を観察します。呼気時に、私は自分の位置を調整します。

システムは横方向に集まるように見えます。**奇静脈系**や**腰静脈**のように、血液循環を再編成します。わずかな熱の変化が知覚できます。

私は空間に注意を払い続け、聞く質を高め、言葉を減らし、徐々に再編成を観察します。

中立、一次呼吸、そしてポテンシア

熱は集中し、その後消散します。まるで体がさらに必要なものを探しに行くかのようです。私たちは二人とも**中立**を取り戻そうとしています。

助けるために、私は**胸式呼吸**と同期します。私の注意は呼気の終わりに向けられ、新しい形への**変容**または変換を可能にします。

プロセスは集まりますが、横方向の力が残ります。私は最後まで伴走し続けます。

心臓、正中線へのこの出会い、**ルーピング**と**側方傾斜**、**回外**と**回内**の動きの表現を持つことが重要です。

発生学的理解と実践

私たちはまた、**肝臓**、**胃**、**大網**の後腔、そして**腸**の発生ダイナミクスについても触れました。

後壁は深く探求され、**腎臓窩**、**副腎**、**生殖腺系**、**子宮**、**前立腺**がすべて正中線に収束するように配置されました。

誕生軸と骨盤を異なる方法で支える方法が議論され、**落ち着き**と**再平衡化**の概念がもたらされました。

中立、**「ミーティングポイント」**、2つの中立の出会いのこの概念が定着し始めています。

それは**一次呼吸**の出現を可能にし、それが徐々に治療プロセス（潮）を活性化します。それは存在し、伴走することです。

あなたの中には**力**、**「ポテンシー」**があり、それを目覚めさせる必要があります。

瞑想と想像力の重要性

心を安定させるために**瞑想**を訓練することが不可欠です。それはより多くの平和をもたらし、最も散漫な人にも推奨されます。

想像力は知性の一形態です。それを現実と混ぜ合わせる方法を知る必要がありますが、どちらかの極端に陥らないようにします。

発生学を見直すことは、解剖学のより良い理解を提供します。発生学は生きた解剖学の確立であり、私たちを構造、機能、形に結びつけます。